EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 79316
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-20 14:35:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MANUEL SEGUNDO GUTIERREZ SANCHEZ			RUN	: 6.030.219-7
F.Nac	: 18-07-1952	Edad	: 71 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: ROBLE VIEJO PARC.12 FONO ACT.			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-17	Fecha Egreso	: 2024-02-20 14:35:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J12.8-NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS (SOSPECHA COVID 19)

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Neumonia adquirida en la comunidad basal izquierda por COVID 19
2. Infeccion x COVID 19
3. Enfermedad de Parkinson
4. Hipotiroidismo
a. 2dario a tiroidectomía por cáncer de tiroides (hace mas de 30 años)
5. Enfermedad ateromatosa coronarias y aorta

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J12.8-NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS (SOSPECHA COVID 19) (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G20.X-ENFERMEDAD DE PARKINSON (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E03.9-HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 71 años con antecedentes descritos es derivado de APS San Nicolas el 16/02 por síndrome febril de 1 dia de evolución, con Test de antígeno Positivo para COVID 19.
Al ingreso paciente normotenso, afebril, saturación Oxigeno 95% ambiental, MP (+) SRA. Se inicia hidratación parenteral, analgesia EV, se solicitan HCT y se inicia tratamiento con ceftriaxona 2 g EV. Se decide hospitalización en servicio de medicina en aislamiento.
Se solicita en servicio de Urgencia AngioTC que descarta TEP, evidencia neumonía en lóbulo inferior izquierda, enfisema ateromatosa de la aorta torácica y coronarias. Minimo enfisema pulmonar difuso.
Durante estadia hospitalaria paciente progresa en buenas condiciones generales, sin fallas organicas, sin requerimientos de oxigeno, por lo que se decide hospitalización domiciliaria, se suspende ATB ya que neumonía es de origen viral y solo requiere manejo sintomático y kinesioterapia y seguimiento por fonoaudiologia. Completar aislamiento designado por IAAS hasta el 25/02/2024.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo asistido
2. 2. Régimen papilla
3. 3. Aislamiento Gotitas Por Covid 19 Positivo hasta 25/02/2024
4. 4. Paracetamol 1 g cada 8 h VO.
5. 5. Bromuro De Ipratropio inhalador 2 puff cada 4 horas por AEC
6. 6. Brexotide Inhalador 2 puff cada 12 horas por AEC
7. 7. Tratamientos crónicos:
8. a. Levotiroxina 200 mcg de lunes a sabados y el domingo descansa

9. b. Pramipexol 1 Mg 1/2 Comp Cada 8 Horas Oral
10. c. Levofamil (Levodopa 250 Mg+ Carbidopa 25 Mg) 1/2 Comp Cada 2 Horas
11. d. Quetiapina 50 Mg 1 Comp En La Noche
12. 8. Prevención UPP
13. 9. Kinesioterapia motora y respiratoria
14. 10. Seguimiento por fonoaudiología
15. 11. Completar aislamiento designado por IAAS hasta el 25/02/2024.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorio 20/02 Albumina 3.1, Crea 0.6, Calcio 8.1, Ca corregido PCR 34.2; Na 142; K 3.5, Cl 107. Leucocitos 8.2, hb 12.3, plaquetas 262.000, VHS 24,
Ph 7.48, pco2 37.1, po2 79.2, HCO3 28.1, EB 5, SatO2 94%

Lab 17/02 GLICEMIA 92 CREATININA 0,70 AMILASA 62 LIPASA 52
CK122 CK MB 15 PCR 51,9 UREMIA 54 SODIO 134,00 POTASIO 4,20 CLORO 97,00 REC LEUCOCITOS 9,4 INR 1,15
GASES VENOSOS . PH 7,36 ,PCO32 50,3, PO2 31,6 ,HCO3 ACT 28,4
17/02/2024 00:56 ORINA COMPLETA. HEMATIES 2 -5 X CAMPO , LEUCITOS 2-5 X CAMPO , BACTERIAS ESCASA CANTIDAD

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO